

מדיניות המרכז הרפואי הדסה נוהל טיפול פליאטיבי בתינוק הנוטה למות בטיפול נמרץ פגים ויילודים מספר: 02-02-05-49			
הספר: 02 – שירותי רפואה	התחום: 02 – מחלקות אשפוז		
הנושא: 05 – ילדים ויילודים	נוהל: 49 - טיפול פליאטיבי בתינוק הנוטה למות בטיפול נמרץ פגים ויילודים		
מהדורה: ראשונה	פרסום: אפריל 2025	עמוד 1 מתוך 20	
הנוהל נכתב ע"י: נכתב על ידי פרופ. סמדר אבן טוב פרידמן מנהלת המערך לנאונטולוגיה, פרופ. זיוונית ארגז מנהלת יחידת פגים ויילודים הצ (לשעבר), ד"ר נעה אופק שלומאי מנהלת מחלקת פגים וילודים עכ, ד"ר סינאן אבו לייל מנהל מחלקת פגים ויילודים הצ, טליה ויזנר אחות ראשית פגיה הצ, טליה לב אחות ראשית פגיה עכ, ד"ר אלכסנדרה ליטווין רוקחת קלינית בפגיות, רבקה מזרחי עו"ס פגיה עין כרם (לשעבר), אסתר רוטנברג עו"ס פגיה הר הצופים, אמונה לייכטר פסיכולוגית פגיה עכ (לשעבר)			
הנוהל אושר ע"י: פרופ' סמדר אבן טוב פרידמן מנהלת מחלקת נאונטולוגיה.			
גורם מתאם בבית החולים: ציפי עזריה שיפמן מנהלת תחום נהלים וסטנדרטים מקצועיים, המערך לאיכות ובטיחות			
תחומי האקדמי: COP 08.00 (גירסה 8 JCI)			
הנוהל מיועד לנשים ולגברים כאחד			

1. מבוא

1.1 סוגיות בנושא סוף חיים ומוות של ילודים ותינוקות הינן טעונות ומורכבות ומהוות נושאים שהשיח בהם רגיש

ורב עוצמה, בין היתר, בשל ההשלכות המורכבות מבחינה קלינית, משפטית, ביו-אתית ופסיכוסוציאלית-רוחנית. חוק החולה הנוטה למות תשס"ו- 2005 (סימוכין 1,2) יצר מסגרת חוקית אשר בבסיסה קיימת ההכרה בזכותו של אדם הנוטה למות (מטופל הסובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו, אף אם יינתן לו טיפול רפואי, אינה עולה על שישה חודשים), (שלא להאריך את חייו בניגוד לרצונו, וזאת בהסדרת הטיפול הרפואי, תוך ניסיון ליצור איזון בין ערכי אוטונומיית האדם ואיכות חייו לבין עקרונות קדושת החיים. בתוך כך, החוק והתקנות שהותקנו על-פיו קובעים תהליך הדרגתי לשם קבלת החלטות באשר לטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות. החוק אינו מחריג פגים וילודים אך גם לא מתייחס אליהם ספציפית. ניתן למצוא בו התייחסות לקטין ולחסוי. לא אחת, במהלך הטיפול בתינוקות חולים עם פרוגנוזה קשה, עולה הסוגיה שטיפול מיטבי יציל את חייהם אך יותיר אותם נכים תפקודית והתפתחותית ובאיכות חיים מאוד נמוכה. למצב זה אין התייחסות בחוק.

1.2 בהתייחס לקטינים, החוק קובע כי הורה של קטין הוא נציגו החוקי לעניין הטיפול הרפואי בו, בין לעניין הארכת

חייו ובין לעניין הימנעות מהארכת חייו. כמו כן קובע החוק כי לעיתים ממנים לקטין אפוטרופוס, בנוסף להוריו או במקומם, אך במקרה זה לא שוללים לחלוטין את אפוטרופוסותם של ההורים. אם האפוטרופוס הוא "אדם קרוב", הוא רשאי להביע את דעתו בנוגע לטיפול הרפואי בקטין והרופא האחראי רשאי לפעול על פיה. אם אין לקטין הורים כלל, או שאפוטרופוסותם עליו נשללה לחלוטין על ידי בית המשפט – ולא מונה לקטין אפוטרופוס אחר, או שהאפוטרופוס שמונה איננו "אדם קרוב", תכריע בעניין הטיפול בקטין וועדה מוסדית. כאשר קיימת אי הסכמה בין הורי הקטין, או אי הסכמה בינם לבין הרופא האחראי והצוות המטפל, בקשר לאופן הטיפול בקטין, החוק קובע שהוועדה המוסדית היא המוסמכת להכריע. (סעיף 47 א, 2, 3)

1.3 כמו לכל חולה, חלה גם על הקטין הוראת החוק המאפשרת הימנעות מטיפול רפואי: החוק אומר כי מותר

להימנע מחידוש טיפול רפואי רציף, שנפסק שלא במכוון או שלא. כמו כן, מותר להימנע מחידוש טיפול רפואי מחזורי, והכל בכפוף להוראות (סעיף ד 21). את ההחלטה על הימנעות מהטיפול יכול לקבל רק רופא אחראי שהוא מנהל מחלקה או מנהל יחידה (פרק ב).

1.4 טיפול תומך בסוף החיים (פליאטיבי) ניתן לתינוק לאחר שהתקבלה החלטה שאין דרך רפואית להצלתו או

להארכת חייו. החלטה זו מתקבלת בהידברות עם ההורים ורק לאחר הסכמתם המלאה. הגישה הפליאטיבית



רואה במוות תהליך טבעי ולא נועדה לזרז או לעכב אותו. הטיפול התומך נועד לאפשר איכות חיים טובה ככל האפשר עד למוות. מטרת הטיפול התומך בסוף החיים (הטיפול הפליאטיבי) היא למנוע סבל ולהקל על התינוק הסובל ממחלה חשוכת מרפא. זאת באמצעות זיהוי יזום של תסמינים כמו כאב, אי שקט ומצוקה, ומתן טיפול מתאים. בנוסף, ישנה התייחסות להתמודדות הנפשית של בני המשפחה המלווים את התהליך, על מנת לאפשר להם להתנהל בצורה מיטבית עם מחלת ילדם.

1.5. בניר העמדה הנוכחי של האיגוד הנאונטלי (סימוכין 4) שמתייחס לטיפול בתינוק הנוטה למות ואשר מהווה המשך ומשלים לנספח 3 המופיע בהנחיה הקלינית " מניעת כאב ביילודים" 2 של האיגוד משנת 2020 (סימוכין 3) יש התייחסות לשתי שאלות עקרוניות בהלימה לרוח חוק החולה הנוטה למות:

1.5.1. האם מותר לבצע אקסטובציה כאשר מטפלים בילוד הנוטה למות?

1.5.1.1. זו דילמה המורכבת הנוגעת להחלטה על מעבר מהנשמה פולשנית להנשמה לא פולשנית בילוד הנוטה למות אם יש רושם שיעמוד בכך.

1.5.1.2. זאת, בהתבסס על הוראות סעיף 21 לחוק החולה הנוטה למות:

1.5.1.3. אין לנתק יילוד ממכונת הנשמה אם ידוע כי פעולה זו תביא למותו המיידי (איסור הפסקת טיפול רפואי רציף, להלן). במידה ואין עוד צורך בהנשמה פולשנית בתינוק שהוחלט כי לא יבוצעו בו פעולות החייאה בעתיד, ניתן לבצע אקסטובציה, אם נראה שיש אינדיקציה רפואית המאפשרת זאת (כגון לחצי הנשמה שאינם גבוהים, ריכוז חמצן נמוך ודחף ("drive") נשימתי. במקרים אלו ניתן לעבור לתמיכה נשימתית לא פולשנית. אם הילוד מסתדר עם הנשמה לא פולשנית ורק בהמשך מופיעה אי ספיקה נשימתית, ניתן, כחלק מטיפול פליאטיבי, לא לבצע אינטובציה.

1.5.1.4. איסור הפסקת טיפול רפואי רציף – ציטוט מהחוק.

1.5.1.5. "אין בהוראות חוק זה כדי להתיר הפסקת טיפול רפואי רציף בחולה הנוטה למות, העלולה להביא למותו, בין שהוא בעל כשרות ובין אם לאו; ואולם מותר להימנע מחידוש טיפול רפואי רציף, שנפסק שלא במכוון או שלא בניגוד להוראות כל דין וכן מותר להימנע מחידוש טיפול רפואי מחזורי, והכל בכפוף להוראות סימן ג'."

1.5.2. האם שימוש בתרופות נגד כאב ולהרגעה עלולות לגרום לדום נשימה ולזרז מוות?

1.5.2.1. בהסבר לחשש כי התרופות אנלגטיות וסדטיביות עלולות לקצר את זמן ההישרדות בזמן הגסיסה עומדים תיאורים ישנים על נשימה שטחית במבוגרים החולים במחלה ריאתית כרונית וטופלו בתרופות אלו, אך אין עדויות בספרות לקיצור תהליך הגסיסה. כמנגנון המוצע לכשל הנשימתי בחולה הנוטה למות, כנראה מדובר על תשישות ממאמץ נשימתי וחרדה המלווים את הקושי הנשימתי ולא דיכוי נשימתי (אפנאה) בשל השפעת התרופה עצמה, ולכן טיפול נגד כאב וחרדה עשוי דווקא להועיל ובעיקר לא להזיק. בנוסף, נראה כי סדציה ואנלגטיקה (אופיאטים ובנזודיאזפינים) אינם מקצרים הישרדות לאחר שניתנים כטיפול פליאטיבי בחולה הנוטה למות ואף יתכן כי מאריכים חיים.

1.5.2.2. פורסמו עבודות במבוגרים וילדים, אך לא נמצאו עבודות בפגים וילודים. בעבודות אלו מתן אופיאטים ובנזודיאזפינים לחולים בתהליך הגסיסה לא גרם לדום נשימה (אפנאה) או זרז את המוות, ובחלק מהעבודות אף עיכב אותו מעט, בהשוואה למי שלא קיבלו טיפול זה.

1.5.2.3. הפרוטוקול הנוכחי מתמקד במרכיבים שתפקידם לאפשר התמודדות משולבת טובה, רגישה ומכבדת במקרה של תינוק הנוטה למות, המשפחה והצוות בטיפול נמרץ פגים



ויילודים, כדי להפחית ו/או למנוע סבל ולאפשר איכות חיים טובה, כמידת האפשר, עד למוות, ומשלב את עקרונות נוהל הטיפול בסוף החיים במרכז הרפואי הדסה (סימוכין 5).

2. מטרה

2.1. לספק מדריך משולב לצוות הרפואי, הסיעודי והפרא רפואי הרב-תחומי לטיפול תומך בתינוק הנוטה למות ביחידה לטיפול נמרץ בפג ובילוד ולתמיכה במשפחתו.

3. חלות

3.1. נאונטולוגים ורופאי ילדים בסבב ו/או שסיימו סבב התנסות בפגיה, אחיות טיפול נמרץ ביחידות לטיפול נמרץ ומיוחד בפג ובילוד וצוותים רב-מקצועיים המטפלים ביילודים מורכבים (עו"ס, פסיכולוג, מרפאים בעיסוק, מלחים רוחניים ומטפלים הקשורים למקרה).

4. סמכות ואחריות

4.1. רופאים הבכירים ביחידות לטיפול נמרץ ומיוחד ביילוד בשיתוף הצוות הסיעודי והרב-מקצועי יתוו את צורת הטיפול ויגבשו עם ההורים את תכנית הטיפול בתינוק הנוטה למות.

5. הגדרות

5.1. "טיפול תומך בסוף החיים (פליאטיבי)": טיפול הניתן לתינוק לאחר שהתקבלה החלטה חד-משמעית שאין דרך רפואית לריפוי (כולל חיים "ראויים" וחסרי סבל) או להארכת חיו. ההחלטה למעבר לטיפול פליאטיבי (או re-direction of care) מתקבלת בהידברות מול ההורים ורק לאחר הסכמתם המלאה ובסיועם עם הצוות הרפואי.

5.2. "מניעת טיפול (withhold)":

5.2.1. קבלת החלטה עקרונית להימנע מהתחלת טיפולים נוספים ייחודיים, או העלאת מינון של טיפולים קיימים, אם וכאשר מתעורר הצורך בהם, בהווה ובעתיד, בחולה הנוטה למות.

5.2.2. לקבוצה זו שייכת גם ההוראה הרפואית - DNR – DO NOT RESUSCITATE - שמשמעותה הימנעות מביצוע החייאת לב ריאה במקרה של הפסקת נשימה או דום לב (כלומר הנשמה מלאכותית, עיסוי לב ומתן תרופות החייאה), לאחר שנתקבלה החלטה כזו עם המשפחה.

5.3. "הפסקת טיפול (withdrawal)":

5.3.1. קבלת החלטה להפסיק טיפול שכבר הוחל בו בעבר ועדיין ניתן לחולה.

5.3.2. יש לציין שגמילת חולה מתרופות אינוטרופיות או הורדה במדדי הנשמה מלאכותית על פי הוריות רפואיות אינה מוגדרת כהפסקת טיפול.

6. שיטה

6.1. קווים מנחים ומתווה לטיפול בילוד בשלבי סוף החיים כשהוחלט לגביו על טיפול פליאטיבי:

6.1.1. קבלת החלטות לאסטרטגית טיפול פליאטיבית עם ההורים, המשפחה והצוות המטפל בתינוק:

- מטרת הצוות הרפואי לעזור להורים להבין את המצב הרפואי של ילדם ואת הפרוגנוזה, להציג בפניהם את אפשרויות הטיפול השונות, לסייע להורים להבין את המשמעויות של הבחירות העומדות בפניהם ולתמוך בהם בכל החלטה שיקבלו, על פי תקוותיהם, פחדיהם וערכיהם התרבותיים-דתיים.



- ההורים צריכים להבין מה משמעות האבחנה של התינוק ואיזה השלכות יש להארכת הסבל.
- יש לוודא שההורים הבינו נכון את מצב התינוק ולציידם במכתב המתאר את מצב התינוק ואבחנתו, על מנת שבעת פנייתם לעצה ממקור חיצוני העובדות יהיו מדויקות.
- ההורים מתבקשים להחליט מה יעשה בעת התדרדרות אקוטית במצב התינוק, ומה תכלול ההחלטה במקרה זה. הליך זה יכול לכלול מספר פגישות עם המשפחה.
- שיחות אלה ילוו באנשי צוות מתחומים שונים הרלבנטיים לטיפול בילוד ולליווי המשפחה כולל אחיות ועו"ס.
- חשוב להישאר צנועים וסקרנים כלפי עמדות ההורים בהבנתנו את הסיטואציה, להשתמש בשפה המתאימה למשפחה, וכן יש להיות רגישים להבדלים תרבותיים.

• השיחות עם ההורים הכוללות החלטות על טיפול חומל צריכות להיות מתועדות.

6.1.2. התנהלות הצוות הרפואי-סיעודי-פארא-רפואי בעת טיפול פליאטיבי בתינוק:

- ההחלטה שהתקבלה עם ההורים תועבר לכל הצוות.
- כעקרון, רצויה תמימות דעים של הצוות המטפל, הרפואי והסיעודי, ואחידות בהחלטות ובביצוען.
- יש לעשות ככל הניתן לתמוך במשפחה על ידי צוות המחלקה כולו עו"ס, פסיכולוג, מלווה רוחנית, טיפול במוסיקה, ועוד.

• רצוי לשים לב לנקודות הבאות:

- כל אחד מהצוות יכול לומר בקול את הרגשתו ולבקש עזרה או החלפה בטיפול.
- תמיד יש משהו נוסף בצוות (הרפואי והסיעודי) שיכול לקחת על עצמו את הטיפול במקרה של קושי.
- בכל נקודה בזמן ניתן להעריך מחדש את ההחלטות ולשנות את תכנית הטיפול.
- הצוות הפסיכוסוציאלי של המחלקה עומד לרשות הצוות וניתן לפנות גם באופן פרטני

לקבלת ייעוץ ותמיכה

6.1.3. ניטור סימנים חיוניים:

הקביעה לגבי ניטור תעשה פרטנית לכל תינוק. ברוב המקרים בשלב סוף החיים ניתן להסתפק בניטור בדופק-נשימה (ללא מדידת לחץ דם). יש לעדכן גבולות אזעקה במוניטור או להפסיקם ALARMS OFF.

6.1.4. בדיקת דם:

הקביעה לגבי בדיקות דם תעשה פרטנית לכל תינוק. ברוב המקרים אין צורך בלקיחת בדיקות דם.

6.1.5. הזנה:

- אין להפסיק מתן נוזלים ו/או והזנה פראנטרלית. צורת המתן והכמות תקבע פרטנית לכל ילוד.
- המטרה של הזנה בסוף החיים היא למנוע מצוקה ועקה בעקבות תחושת רעב (COMFORT FEEDING = אוכל מנחם).
- הכמות צריכה להיות מספיקה לתחזוקת מערכות הגוף והאפשרות לקיום התהליכים המטבוליים הבסיסיים הנדרשים לקיום החיים. אין מטרת ההאכלה לספק הזנה שתביא לעליה במשקל.
- הפסקת אוכל אנטרלי תעשה רק אם יהיה רושם כי מתן האוכל עצמו גורם לכאב ואי-שקט או במקרים בהם קיימת וודאות כי המזון מקצר חיים (כמו רפלוקס קשה הגורם להשתנקות).
- אין צורך בהחלפת זונדה שגרתית.



6.1.6. שאיבת הפרשות מדרכי נשימה:

- תבוצע כטיפול מקל אם יש רושם למצוקה סביב הפרשות מרובות.

6.1.7. שיכון כאב או הפחתת מצוקה במהלך טיפול תומך בתינוק הנזקק למות:

6.1.7.1. הטיפול יעשה באמצעות זיהוי יזום של תסמינים (כגון כאב, אי שקט, ומצוקה) ומתן טיפול

מתאים שיאזן את התסמינים ככל האפשר **במשך כל שעות היממה**. ניטור היילוד לסימנים פיסיולוגיים המעידים על אי נוחות או מצוקה יעשה בעזרת סרגל NPASS (נוהל טיפול בכאב בילוד 02-02-05-50). יש לבצע אומדן כאב לפחות אחת למשמרת, ולבצע אומדן כאב חוזר לאחר מתן טיפול.

6.1.7.2. **הפעולות לשיכון כאב והפחתת מצוקה כוללות טיפולים שאינם פרמקולוגיים ותרופות.**

6.1.7.3. טיפולים לא פרמקולוגיים לתחושת כאב ו/או מצוקה כוללים:

- סקשן עדין, שינוי תנוחה – להפרשות.
- שינוי תנוחה, תיחום, עיטוף
- מגע עמוק, מגע עור לעור, קנגורו,
- ארגון הסביבה והפחתת גרייה עודפת (שקט, עמעום אורות וכו')
- מוסיקה לבחירת ההורים
- מתן סוכרוז / חלב אם
- מוצץ, מציצה לא לשם האכלה
- החזקה / אחיזה בידי המטפל
- MINIMAL HANDLING: הפחתת כמות פרוצדורות / הפחתת תדירות הפרעות
- ארגון מנחים (תנוחה שהגפיים בפלקסיה ומקורבים לגוף)
- טיפול ב 4 ידיים במידת האפשר
- כיבוד רגעי שינה ורגעי רוגע
- תנועה והנעה
- נוכחות הורית ומעורבות בטיפול

שילוב של מספר טיפולים נמצא יעיל במניעת כאב והטיפול בו. כמו כן נמצא כי

אסטרטגיות אלו מעצימות את האפקט של תרופות אנלגטיות.

6.1.8. **טיפול תרופתי בזיהוי סימני מצוקה וכאב:**

מצ"ב המלצות טיפול למצבים הבאים: (יש ללחוץ על הקישור)

[כאב / צורך בסדציה.](#)

[דיספנאה,](#)

[פרכוסים,](#)

[אי-שקט/אגיטציה,](#)

[ספסיות,](#)

[הפרשות מרובות בדרכי הנשימה.](#)

מומלץ לבצע טיטרציה ממוננת נמוך לגבוה בהתאם למצב הרפואי ולתגובת התינוק.



6.1.9. קיום מנחים לאירוע החייאה במקרה של תינוק בסוף החיים

רצוי להתוות הנחיות טיפול ברורות וכתובות לצוותים המטפלים על פי החלטות עם ההורים, כגון:

- 6.1.9.1. ללא שימוש באדרנלין כתרופת החייאה.
- 6.1.9.2. אין צורך בביצוע אינטובציה כפעולת החייאה.
- 6.1.9.3. אין צורך במתן הנשמות בלחץ חיובי ע"י אמבו או ניאופף כפעולות החייאה.
- 6.1.9.4. אין צורך בפעולות עיסוי לב כפעולת החייאה.
- 6.1.9.5. המשך תמיכה נשימתית לא פולשנית.
- 6.1.9.6. גמילה ממדדי תמיכה נשימתית בהתאם לאפשר מבלי להעלות חזרה תמיכה.
- 6.1.9.7. המשך תמיכה עם העשרת חמצן.

6.1.10. ליווי המשפחה במהלך טיפול פליאטיבי ולקראת סוף החיים של תינוקם:

- 6.1.10.1. מעטפת תמיכה פרא-רפואית רב-תחומית במצבים אלו הינה חיונית, מאחר ויש ביכולתה לסייע להורים בתהליך האבל והאובדן. ליווי זה מאפשר להורה להנכיח את קיומו של התינוק שנים רבות לאחר האובדן. ([נספח 1](#), התמודדות הורים עם סוף החיים, [נספח 2](#) מכתב מצוות הפגייה להורים).
- 6.1.10.2. יש להסביר להורים מראש על סימפטומים סביב תהליך המוות, כולל gasping ושינוי צבע. יש להדגיש כי תסמינים אלו בהכרח מצביעים שילדם סובל וכי יינתן טיפול מקל כאב ותחושת מצוקה בכל חשד לתחושה שכזו.
- 6.1.10.3. תיעשה הדרכה של ההורים בנוגע לתהליך האבל והאובדן, לרבות האופן שבו אימהות ואבות, ובני משפחה אחרים, היכולים להתאבל באופנים שונים.
- 6.1.10.4. יש להציע להורים ולעודד אותם, בעדינות ובהתאם לתגובתם, להחזיק את הילוד על הידיים, ולצלם תמונות למזכרת, לפני ואחרי הפטירה.
- 6.1.10.5. בעת גסיסת התינוק, בתאום עם הצוות הרפואי והסיעודי ובשיתוף ההורים יש לשאוף לאפשר להורים לשהות בפרטיות עם תינוקם וניתן להרחיב את מעגל המבקרים המגיעים לשהות יחד עם ההורים והתינוק (דודים, חברים וכו' – לפי החלטה פרטנית).
- 6.1.10.6. בתיאום עם המשפחה יש להתקשר להורים לידע בעת התדרדרות או לברר עם המשפחה איזה עדכונים ברצונם לקבל בטלפון.
- 6.1.10.7. יש לסייע לאם המבקשת לייבש חלב ([נספח 3](#))

6.1.11. אפשרות לשמירת זיכרונות מהתינוק:

- 6.1.11.1. זיכרונות מהתינוק מאפשרים להורים ליצור נרטיב קוהרנטי שיוכלו לשזור לתוך המארג המכיל את סיפור חייהם. העלאת זיכרונות והכרה בתינוק ובחשיבותו עבורם מקל ומסייע לתהליך האבל והאובדן ועל היכולת של ההורה להסתגל לעתיד ללא תינוק. משכך, יש להציע להורים ולעודד אותם, בעדינות ובהתאם לתגובתם, להחזיק את הילוד על הידיים, וליצור מזכרות בחלון ההזדמנויות הצר הקיים לרשותם:
 - שמירת חפצים שהביאו מהבית (שמיכה, בובה רכה, מוצץ).
 - במצבים שבהם הפטירה סמוכה ללידה ואין להורים את הזמן להביא חפצים משלהם, מומלץ לתת להורים חפצים ופריטים המצויים באופן נגיש ומיידי בפגייה ואשר באו במגע עם התינוק (חיתול בד, כובע סרוג, בובת תמנון).
 - צמידי זיהוי של התינוק וההורה, כרטיס "נולדתי", וכו'.



- במידה וההורים אינם מעוניינים בשמירת חפציו של התינוק, מומלץ לארוז את החפצים ולסמנם במדבקת זיהוי. את הערכה יש לשמור במקום ייעודי בפגיה, עד שההורים יהיו בשלים להגיע לקחת אותה.
- כדאי לעודד, בעדינות, לצלם תמונות של התינוק. גם הורים הנרתעים תחילה, לרוב ימצאו בהמשך את התמונות כמשמעותיות.
- רצוי לצלם את התינוק בעודו בחיים אך אם הדבר לא מתאפשר מומלץ ורצוי לצלמו לאחר הפטירה, **במועד כמה שיותר סמוך לפטירה** (בשל השינויים הפיזיולוגיים).
- **הטבעות ידיים/רגליים של התינוק:**
ניתן לרכוש ערכות ייעודיות ליצירת הטבעות של ידיים ורגליים בדיו ובחמר, ניתן להציע להורים ערכות אלו, פעמים רבות ההורים מעוניינים להיות נוכחים ולקחת חלק ביצירת הערכה יחד עם אנשי הצוות וחשוב לאפשר ואף לעודד זאת.
ניתן להציע להורים לצלם את תהליך הכנת הערכה שכן גם תצלומים אלו יכולים להישמר כמזכרת בפני עצמה.
- **שמירת תלתל:** אפשר להציע להורים לגזור תלתל משיער התינוק למזכרת. יצוין, כי ישנם הורים שמסיבות דתיות / אישיות אינם מעוניינים בתלתל שיער הואיל והם מעוניינים שהתינוק יובא לקרובה "שלם".

6.1.12. הליך טיפול בתינוק שנפטר:

הטיפול בילוד הנפטר הינו מורכב ומאתגר. לעיתים מדובר בפג קטן שחי שעות או ימים בודדים, לעיתים בתינוק החולה במחלה מסכנת חיים, ולפעמים תינוקות בריאים במועד שעברו סיבוך בעת הלידה. מצבים שונים אלו מורכבים לטיפול והתמודדות. תהליך הטיפול בנפטר כולל מספר תחומים שיש לוודא שכולם בוצעו בשלמות על מנת לסיים את הטיפול באופן תקני.

פירוט הליך הטיפול בנפטר [בנספח 4](#).

6.1.13. שיחת follow-up עם ההורים לאחר המוות:

רצוי ביותר ליצור קשר טלפוני עם ההורים (על ידי הצוות הפסיכוסוציאלי המחלקתי) מספר ימים לאחר האובדן. מעבר לדרישה בשלומם של ההורים השיחה היא מחווה אישית חשובה עבורם כמו גם עבור הצוות שהיה אמון על הטיפול בתינוק. ניתן להציע פגישה עם המשפחה באם ירצו לסיכום, שאלות ובקשות. ניתן במסגרת שיחה זו גם לידע את ההורים באפשרויות הטיפול השונות בקהילה המתמחות בתמיכה בשכול לאחר אובדן תינוק. ([נספח 2](#))

6.1.14. תמיכה בצוות המטפל:

טיפול ותמיכה במשפחות בשעת אבל ואובדן במסגרת פליאטיבית היא אינטנסיבית וכרוכה בדחק נפשי של הצוותים הרפואיים, הסיעודיים והפרא-רפואיים. אלה נמצאים בסיכון לשחיקה הן בעקבות הליווי הצמוד של המשפחות ברגעיהן הקשים ביותר, תוך שהם נדרשים להיות עדים לקבלת החלטות קשות ולחשיפת המשפחות למצבם הקשה של תינוקם, והן בשל הקושי הכרוך בטיפול עצמו בתינוק הנוטה למות. כיוון שכך הצוותים הרפואיים נמצאים בסיכון מוגבר לתשישות החמלה-שחיקה המוגדרת כתשישות פיזית, רגשית ומנטאלית הנובעת ממעורבות ארוכת טווח במצבים תובעניים רגשית-, תסמונת דחק פוסט-טראומתית משנית, ובכלל שחיקה מוגברת בשל החשיפה למצב קיצון זה. כיוון שכך ישנה חשיבות גבוהה לכך שהצוות יקבל את התמיכה הרגשית והנפשית והמרחב לעיבוד ושיתוף במהלך הטיפול בתינוק הנוטה למות ולאחר כל תמותה של תינוק. קבלת תמיכה זו תיעשה על ידי הצוות הפסיכוסוציאלי במחלקה, באופן קבוצתי או פרטני, לפי הצורך. רצוי לכוון שגרת התכנסות של



הצוות הרפואי בהתאם לדיספלינות השונות עם הצוות הפסיכוסוציאלי, בשגרה בכלל ובפרט סביב טיפול בתינוק הנוטה למות ובעקבות פטירה של תינוק. הצוות יוכל לפנות באופן פרטני ליעוץ ותמיכה הן לצוות הפסיכוסוציאלי במחלקה (לתמיכה ממוקדת יותר) והן למערך התמיכה הפרסונלית בבית החולים.

7. הכשרה והטמעה

- 7.1. הנוהל יופץ לעובדים באופן ישיר למייל האישי שלהם בהדסה ועל-ידי המנהלים הישירים.
- 7.2. הדרכה בנוגע לנוהל זה תינתן בעת קבלת עובד חדש למחלקה.
- 7.3. באחריותם של מנהלי המחלקות והאחיות הראשיות להטמיע נוהל זה בקרב העובדים שלהם.

8. סימוכין

- 8.1. חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005: החוק בראי הפרקטיקה הרפואית ועיוני משפט. https://www.taulawreview.sites.tau.ac.il/m-1-1/karako_gelber_peled
- 8.2. [משרד הבריאות. חוק החולה הנוטה למות.](#)
- 8.3. הנחיות קליניות האיגוד הישראלי לנאונטולוגיה, [מניעת כאב ביילודים](#), דצמבר 2020
- 8.4. נייר עמדה של האיגוד הנאונטלי: [טיפול תומך ביילוד הנוטה למות](#)
- 8.5. נוהל הדסה: נוהל טיפול בסוף חיים 02-12-01-01.
- 8.6. Garten L, Bühner C. Pain and distress management in palliative neonatal care. Semin Fetal Neonatal Med. 2019;24(4). doi:10.1016/j.siny.2019.04.008
- 8.7. Maher-Griffiths C. Perinatal Palliative Care in the Neonatal Intensive Care Unit. Crit Care Nurs Clin North Am. 2022;34(1):103-119. doi:10.1016/j.cnc.2021.11.008
- 8.8. Chen Y, Jiang J, Peng W, Zhang C. Palliative sedation for children at end of life: a retrospective cohort study. BMC Palliat Care. 2022;21(1). doi:10.1186/s12904-022-00947-y
- 8.9. Lantos JD. Ethical Problems in Decision Making in the Neonatal ICU. New England Journal of Medicine. 2018;379(19):1851-1860. doi:10.1056/nejmra1801063
- 8.10. Verhagen AAE. Neonatal euthanasia in the context of palliative and EoL care. Semin Fetal Neonatal Med. 2023;28(3). doi:10.1016/j.siny.2023.101439
- 8.11. Akyempon AN, Aladangady N. Neonatal and perinatal palliative care pathway: A tertiary neonatal unit approach. BMJ Paediatr Open. 2021;5(1). doi:10.1136/bmjpo-2020-000820
- 8.12. Cortezzo DME, Meyer M. Neonatal End-of-Life Symptom Management. Front Pediatr. 2020;8. doi:10.3389/fped.2020.57412
- 8.13. Lago, P., Benini, F., Parravicini, E., Carter, B. S., eds. (2021). Perinatal Palliative Care Lausanne: Frontiers Media SA. doi: 10.3389/978-2-88971-141-3. Frontiers in Pediatrics vol. August 2021
- 8.14. Kenner C, Press J, Ryan D. Recommendations for palliative and bereavement care in the NICU: a family-centered integrative approach. J Perinatol. 2015;35 Suppl 1(Suppl 1):S19-S23. doi:10.1038/JP.2015.145



- Wallerstedt C, Higgins P. Facilitating perinatal grieving between the mother and the father .8.15
J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 1996;25(5):389-394. doi:10.1111/J.1552-6909.1996.TB02442.X
- Meadors P, Lamson A. Compassion fatigue and secondary traumatization: provider self .8.16
care on intensive care units for children. J Pediatr Health Care. 2008;22(1):24-34.
doi:10.1016/J.PEDHC.2007.01.006
- Pines, A., & Aronson, E. (1988). Career burnout: Causes and cures .8.17

9. נספחים

- 9.1. נספח 1: [התמודדות של ההורים עם תינוקם הנטה למות.](#)
- 9.2. נספח 2: [מכתב להורים](#) (מק"ט ח-662)
- 9.3. נספח 3: [הנחיות לאם לגבי ייבוש חלב או שאיבת חלב.](#)
- 9.4. נספח 4: [נוהל טיפול ביילוד שנפטר.](#)
- 9.5. נספח 5: [טיפול תרופתי בזיהוי סימני מצוקה וכאב](#)

**נספח 1: התמודדות של ההורים עם תינוקם הנוטה למות****היבטים רגשיים של הורים סביב פטירת תינוק בפגיה**

בספרות העוסקת בחוויות ההורים לפגים בזמן האשפוז בפגיה מדובר בין היתר על תהליך המקביל לתהליך של אבדן, גם כאשר אין מדובר בתינוק הנוטה למות. אבדן של הציפייה ללדת תינוק בריא, קטיעה, בדרך כלל טראומטית, של ההיריון ואבדן של חוויית ההורות שלה ציפו. המפגש הראשון של ההורים עם תינוקם החדש מלווה בחרדה קיומית לחייו, התינוק לא נראה כמו תינוק "רגיל", הוא בדרך כלל קטן מאוד ומחובר ללא מעט צינורות ומכשירים שלא מאפשרים לראות אותו כמו שצריך. הורים מדווחים על תחושות של אשם, חרדה, חשש להיקשר לתינוק, חוסר אונים, חוסר קומפטנטיות ועוד..

אחת המטרות של צוות הפגיה (רופאים, אחיות, צוות פסיכוסוציאלי ופרא רפואי) היא להחזיר להורים את התפקיד ההורי ותחושת הקומפטנטיות ובכך לאפשר היקשרות מיטיבה בין ההורים לתינוק.

כאשר הורים מקבלים הודעה על כך שהתינוק שלהם במצב כזה שאין לרפואה יותר יכולת לרפא אותו, החשש הנורא ביותר שלהם מתממש.

השיחה הראשונית בה מדברים עם ההורים על מעבר לטיפול תומך היא שיחה טראומטית ומבלבלת. לעיתים לוקח זמן להורים לעכל את הנאמר. לפעמים רק אחרי שמסתיימת השיחה מתחילות לעלות שאלות ורגשות שונים מופיעים. לכן, חשוב בנוסף לשיחה הראשונית לאפשר שיחות המשך בזמנים גדולה מהרגיל. בשיחות ההמשך נכון להסביר להורים ביתר פירוט על ההתנהלות עם התינוק בשעות או בימים שנתרו לו. נאפשר להורים לצרף לשיחה את ההורים שלהם או אנשים אחרים ממעגל התמיכה שלהם. הצוות הפסיכוסוציאלי מלווה את ההורים בשיחות עצמן וביניהן, מעריך את מידת ההבנה שלהם את מצב התינוק, בוחן את מצבם הרגשי ונותן כלים שונים להתמודדות.

המעורבות של ההורים בטיפול בתינוק בתקופה הקשה הזו חשובה ביותר לתינוק ולהורים. התינוק יקבל חום ואהבה שיקלו על הסבל שלו וההורים יקבלו אפשרות לתהליך פרידה מותאם והדרגתי.

ישנם הורים שנרתעים מלטפל בתינוק במצב הזה. נכון לעודד אותם לקחת חלק בטיפול בקצב ובאופן המתאים להם. כדי לא לפגוע בתחושת ההורות והקומפטנטיות שגם ככה מעורערת, חשוב לאפשר להם בחירה. זאת אומרת, לידע אותם לגבי האפשרויות השונות אך לא לקבוע מה נכון עבורם.

כדאי להציע להורים להחזיק את התינוק כמה שהם יכולים, לצלם אותו ולהצטלם אתו, לדבר אליו, להתפלל עבורו ובמקביל להיות שותפים בטיפול השגרתי כגון החלפת חיתול ורחצה. ניתן להציע להורים להזמין את האחים/ הדודים/ סבים וסבתות להיפרד מהתינוק.

יש הורים שנכון להם להיות כמה שאפשר ביחידות עם התינוק ולהיפרד ממנו בפרטיות ויש כאלו שההימצאות לבד עם תינוק הנוטה למות מאיימת עליהם והם זקוקים לנוכחות של הצוות. נכון להיות רגישים לכך ולבדוק עם ההורים מה נכון להם.

לאחר הפטירה חשוב להסביר להורים מה עושים עם התינוק (הוצאת העירוניים, ניקוי / רחצה, עטיפה וכו'). ניתן להציע להורים להיות שותפים בטיפול לאחר המוות. יש לאפשר להורים הרוצים בכך, להיפרד מהתינוק גם לאחר ניקוי/רחצה. יש להציע צילום של התינוק, טביעת רגליים/ידיים ואת חפציו האישיים של התינוק (כרטיס יילוד, כובע ותמנון). כל הורה יחליט מה מכל זה נכון לו.



תהליך האבל על אובדן של תינוק בפגיה זהה במובנים רבים לאובדן של אדם קרוב, עם זאת מכיוון שהתינוק מעולם לא יצא מבית החולים, הקשר אתו וכן גם הפרידה ממנו התרחשה במעין בועה, בניתוק מהעולם שבחוץ. בשונה מבן משפחה אחר, את התינוק הנפטר לא הספיקו המשפחה והחברים להכיר. הקשר של ההורים עם התינוק לעיתים היה כל כך מושקע ואינטנסיבי אך מכיוון שאחרים לא היו עדים לקשר הזה, תחושת הבדידות באובדן היא לעיתים קיצונית. לצוות הפגיה יש תפקיד רגשי חשוב מעצם היותם העדים היחידים לקשר והשותפים היחידים של ההורים בהיכרות עם התינוק.

**נספח 3: הנחיות לאם לגבי ייבוש חלב או שאיבת חלב**

אמא יקרה, אנחנו משתתפים בצערך.

דף זה מיועד לעזור לך לטפל בעצמך בזמן הקשה הזה, לאחר פטירת תינוקך.

פטירתו של ילדך הוא הזמן הנורא מכל ואת צריכה את כל התמיכה והעזרה שאפשר לקבל כעת. באם הנקת או שאבת חלב בשביל הילד שלך עד עכשיו, אנו רוצים להציע מה ניתן לעשות כדי שתהליך הפסקת ייצור החלב שלך יהיה הדרגתי.

כדי לתת לגופך סימון להפסיק את ייצור החלב, עדיף לשאוב רק את הכמות שאת צריכה בשביל להרגיש בנוח, על מנת שייצור החלב ירד בהדרגה. את יכולה להרגיש מלאות/גודש, דליפת חלב, אי נוחות ואפילו כאבים בזמן הזה.

להלן כמה המלצות כדי להקל עליך בתקופה קשה זו:

- פניה ליעוץ גניקולוג לקבלת תרופה ליבוש חלב
- רצוי ללבוש חזייה תומכת ולא צמודה מדי.
- פדים יכולים לעזור לספוג את דליפת החלב
- קומפרסים קרים וכן עלי כרוב סביב השד יכולים להקל כאב וגודש
- יש להימנע מחימום יתר של השד.
- ניתן לקחת משככי כאבים על פי הוראות רגילות (אקמול, נורופן).
- יש להוציא כמות קטנה של חלב כל פעם, רק עד לשחרור תחושת הגודש. ניתן לעשות עיסוי עדין/שאיבה ידנית בזמן מקלחת או אמבטיה פושרת – זה משחרר את עודף החלב ללא גירוי נוסף של הפטמות והשדיים ובכך ימנע ייצור יתר של החלב – כי את לא מרוקנת את השד.
- יש להקפיד לשתות ולאכול.

לאלו דברים כדאי לשים לב:

- במידה ומופיע גודש משמעותי – שדיים גדושים, קשים וכואבים – יש לרוקן את השדיים חד פעמית כדי להקל על הכאב. בימים הבאים לנסות להוציא רק כמות החלב מספקת כדי לשחרר את אי הנוחות. יש להשתמש בקירור מקומי ומשככי כאבים כפי שצוין מעלה.
- דלקת בשד – גושים, אזורים אדומים וחמים בשד, חום והרגשה כללי רעה – יכולים להעיד על התחלה של דלקת – במקרים אלו יש לפנות לעזרה מקצועית ורפואית.

כמה זמן נמשך ייצור החלב?

זה מאוד אישי, אך בממוצע לוקח לפחות שבועיים. גם כשהייצור פוחד ממש, עדיין לפעמים יכולה להופיע כמות מועטה של חלב או שתרגישי פתאום את הלחץ/כאב/תחושת שחרור של החלב כתגובה למשהו רגשי. אם יש לך שאלות נוספות בבקשה תפני ליועצות ההנקה במחלקתינו או לרופא/ה המטפל/ת שלך, או לקו תמיכה טלפוני של ליגת לה לצ'ה ישראל בטל: 1599525821.

נספח 4: נוהל טיפול ביילוד שנפטר

מטרה

מתן הנחיות וכלים לצוות הרפואי והסיעודי להתנהלות במקרי פטירה במחלקה. כמו כן תינתן התייחסות לליווי המשפחה בתהליך הפרידה ולהתמודדות הצוות במקרים שונים.

חלות

על כל אחות ורופא במחלקה.

על כל האחיות והרופאים להכיר את חוק החולה הנוטה למות.

סמכות

האחות האחראית תנהל את האירוע על פי הנוהל יחד עם האחיות העובדות באותה משמרת ובהתאמה למצב המטופל, משפחתו והתנהלות המשמרת.

שיטה

1. הודעה על פטירה

הודעה להורים תעשה על ידי רופא במקביל להודעה לעו"ס, אחות ראשית, אחות כללית, מפקחת.

בהודעה להורים יש להבדיל בין 2 מצבים:

- אם התינוק השתחררה מבית החולים ואינה נמצאת- במקרה זה רופא/אחות יצרו קשר עם ההורים ויידעו אותם בנוגע להחמרה במצב ילדם ויבקשו מהם להגיע למחלקה.
- אם התינוק עדין מאושפזת:
 1. האחות המטפלת תיידע את האחיות האחראיות משמרת במחלקה על התדרדרות הילד.
 2. האחות המטפלת במידת הצורך/היכולת (או שתמנה מישהי אחרת) תיצור קשר עם עו"ס שתגיע למחלקה/אחות טיפול תומך.
 3. האחות המטפלת תיצור קשר עם המחלקה שבה האם מאושפזת. במידה והאם לא יכולה להגיע למחלקה רופא ירד בליווי אחות לשוחח איתה.

2. הליך טיפול בנפטר

- האחיות תנסה במידת האפשר להעביר את התינוק לפינה צדדית (ביניים), או לסירוגין סגירת הדלת בחדר טיפול נמרץ כדי לאפשר פרטיות
- הרופא יעדכן את ההורים בפרטי ההידרדרות ותהליך הפטירה הצפוי/ סיבת הפטירה
- האחות/הרופא יהיו זמינים לתמוך בהורים ולאפשר שאלות בנוגע לטיפול סיעודי/רפואי שניתן.
- הרופא/האחות יציעו ויעודדו את ההורים להחזיק את התינוק כשהוא לבוש/עטוף לאחר ניתוק ממכשירים/צנרת.
- האחיות תערב יועצת הנקה בנושא של יבוש חלב.
- האחיות תמצא זמן מתאים בו ילקחו בדיקות כגון א.ק.ג, בדיקת סקר יילודים. בדיקת סקר יילודים תילקח בסמוך למוות בהסכמת ההורים. יש לציין על ניר הדגימה כי התינוק נפטר.
- האחיות תברר מהם מקורות התמיכה של האם והאב, האם הם מעוניינים בתמיכה כלשהי, איש מקצוע, בן-משפחה, איש דת משהו אחר שהיו רוצים לשתף. לברר מי מלווה אותם לביתם בסיום התהליך.
- קביעת מוות ושעת מוות ע"י הרופא: על פי מוניטור/א.ק.ג/האזנה ללב, בהמשך ימולאו הטפסים המתאימים.

- במידת האפשר תתלווה האחות לרופא לשיחות עם המשפחה על המלצה רפואית לבדיקות נוספות במידת הצורך שיילקחו מהנפטר, כמו בדיקות הדמיה, ביופסיה של רקמה, דגימות דם או נתיחה של הגופה (PM). יש להסביר ולתעד את הסיבות להמלצה
- לאחר קביעת המוות יינתן זמן להורים ולמי ממשפחתם להחזיק, להיפרד, להתייחד.
- האחות תציע אפשרויות להנציח את זיכרון היילוד ותפעל בהתאם לרצון ההורים והאפשרויות במחלקה (מתן שם, הכנת מעטפת זיכרון שתכלול: תמונות, שיער, טביעת רגל בדיו, טביעת רגל בגבס).
- העו"ס תדון עם ההורים בנוגע לנושאים הבאים: אפשרויות קבורה, סוגיות העולות כמו שיחה עם ילדים נוספים בבית, המשך אשפוז של האם או שחרור, המשך ליווי, קהילה שרותי בריאות הנפש, זכויות היולדת למרות פטירת היילוד- דמי לידה, חופשת לידה וכו'.
- טיפול בקושי משפחתי אם קיים- להיפרד מהתינוק מול הצורך להשלים את התהליך בזמן סביר
- במידה ונתקלים בקשיים בתהליך הפרידה- חוסר שיתוף פעולה של המשפחה, הימשכות התהליך זמן לא סביר, התנהגות לא ראויה כלפי הצוות, יש לערב גורמים מתאימים (לדוגמא: אחות ראשית או אחראית משמרת, עובדת סוציאלית, רופא, איש דת ואף ביטחון).
- לאחר קביעת המוות ופרידת ההורים הארגון והטיפול בנפטר יעשה ע"י 2 אחיות
- האחות תסדר את הסביבה בה נמצא התינוק ותנתק את כל הצינורות והמכשירים המחוברים לתינוק.
- במידה ויש, האחות תארגן ציוד אישי של התינוק הנפטר (כרטיס לידה, ידונים, מוצץ, בגדים, וכו' יחד עם מעטפת הזיכרון שהוכנה עבורם במידה ויהיו מעוניינים לפתוח אותה)
- הטיפול הפיזי בתינוק הנפטר יתבצע בד"כ כשעתיים לאחר הפטירה. הטיפול כולל: הכנת ציוד הכולל ידונים (שם האם, שם התינוק ות"ז של התינוק), חיתולי בד/ סדין לעיטוף, מסיר דבק, כרטיסי זיהוי (ורוד לבת כחול לבן) עליהם מדבקה עם פרטי התינוק, טפסים למילוי ע"י הרופא (הציוד הנדרש נמצא בתיק "טיפול בנפטר".
- האחות תהדק לתינוק ידונים בשורש כף היד ובקרוסול במידה וחסר.
- האחות תקשור כרטיס זיהוי אחד סביב יד ושני סביב רגלו של התינוק.
- האחות תעטוף את התינוק בסדין ותקשור מעל כרטיסי זיהוי נוסף.

3. תהליך מילוי הטפסים ע"י רופא ואחות

- הרופא ימלא הודעת פטירה ממוחשבת בארבעה עותקים (לפני החתימה יש לוודא שמו של האב ואת דתו, ובמידה ופרטים אלה חסרים יש להתקשר לקבלת חולים שימלאו את החסר). אבחנות רלבנטיות יש לכתוב באנגלית. יש למלא במדויק את תאריך המוות ושעת הפטירה
- עותק אחד של הודעת מכתב פטירה ניתן להורים עותק שני של הודעת הפטירה יועבר לקבלת חולים על ידי בן משפחה ועו"ס, לצורך קבלת רשיון קבורה.
- קבלת רשיון קבורה מקבלת חולים.
- הסבר רפואי על צורך בנתיחת גופה. במידה והמשפחה מסרבת יש להחתימם על טופס יעודי. במידה ומסכימים ל PM יש להודיע לפתולוג כונן ולהתארגן לנתיחה על פי ההנחיות מפתולוגיה.
- טופס העברת תינוק שנפטר ימולא ע"י האחות.
- מילוי תגים וכרטיסי פטירה בשלשה עותקים ע"י האחות.
- הודעה לעובד בית על פטירה

4. על פי נוהל משרד הבריאות והמשרד לענייני דת ההורים רשאים לדעת את מקום קבורת ילדם, ועומדות לפנייהם שלוש אפשרויות בנוגע לניהול קבורת התינוק שנפטר:

- **ההורים אינם רוצים מעורבות:** הם מסמיכים את צוות ביה"ח לטפל בענייני קבורת התינוק.
- **ההורים רוצים מעורבות חלקית:** המשפחה נפרדת מהתינוק ומשאירה את הליכי הקבורה לנציגי חברת הקדישא העובדים עם ביה"ח, ומבקשים להיות נוכחים בעת הקבורה.
- **מעורבות מלאה:** המשפחה לוקחת אחריות מלאה ופעילה על קבורת תינוקם.

5. יש להסביר להורים את האפשרויות והפרוצדורות לקבורה על פי המצוין לעיל. עו"ס מעורבת תוודא מול המשפחה את אפשרויות הקבורה ותעזור בהליכים הנדרשים מול חדר מתים, חברה קדישא וכו'.
6. יש לציין במפורש את סוג הקבורה בה ההורים בחרו.

חשוב: יש לשים לב שכל הטפסים הנדרשים נמצאים, חתומים כראוי והינם העתקים סופיים ורשמיים.

- **יש לדווח ולתעד את האירועים הרפואיים סביב הפטירה בגליון הרפואי, הסיעודי וספר קבלות.**
 - **יש לכתוב סיכום רפואי** במהירות האפשרית. בהר הצופים מכתב זה מועבר להנהלת בית החולים.
- המשך מעקב עם המשפחה יעשה כפי שפורט בסעיף 6.1.1.3 בנוהל.



נספח 4: טיפול תרופתי בזיהוי סימני מצוקה וכאב

Pain/Sedation			
Name of Drug	Dosage	Mechanism of Action	Main Adverse Effects
Dexmedetomidine (Precedex)	IV: Loading doses of 0.05 to 0.2 mcg/kg over 10-20 minutes, followed by 0.05 to 0.6 mcg/kg/hr IV (adjust dose to desired level of sedation) Intranasal: 1-2 mcg/kg	Alpha ₂ adrenergic agonist, activation of the receptors results in sedation.	Bradycardia Hypotension
Fentanyl	Single or intermittent: 0.5 - 3 mcg/kg per dose slow IV push. May repeat every 2 to 4 hours Continuous infusion: 0.5 - 2 mcg/kg/hr. Max dose: 3 mcg/kg/hr. Intranasal: 1-2 mcg/kg Transdermal Patch: 1/4 - 1/2 Patch of 12.5 mcg. Calculate rate per kg individually.	Binds with stereospecific receptors at many sites within the CNS, increases pain threshold, alters pain reception, inhibits ascending pain pathways.	Chest wall rigidity, Respiratory depression occurs on high doses, Urinary retention, Tolerance may develop to analgesic doses with prolonged use; wean slowly.
Morphine	Single or intermittent: 0.05 - 0.2 mg/kg per dose IV, IM, or subQ. May repeat every 4 - 6 hours. Up to 0.08 mg/kg per dose PO every 4-6 hours. Continuous infusion: 0.01 - 0.02 mg/kg/hr. Max dose: 0.03 mcg/kg/hr Buccal: 1/3 - 1/2 oral dosage.	Binds to opioid receptors in the CNS, causing inhibition of ascending pain pathways, altering the perception of and response to pain; produces generalized CNS depression. Use IV solution. Rapid absorption, useful first line if no IV access available/appropriate.	respiratory depression, hypotension and bradycardia. Ileus and delayed gastric emptying, urine retention. Tolerance may develop after prolonged use; wean slowly.
Methadone	- Initial dose: 0.05 to 0.1 mg/kg per dose orally every 6 to 24 hours. Adjust dose (in 10% to 20% increments) and weaning schedule based on signs and symptoms of withdrawal	Binds to opiate receptors in the CNS, causing inhibition of ascending pain pathways, altering the perception of and response to pain; produces generalized CNS depression. Methadone has also been shown to have N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonism	Respiratory depression in excessive doses. Ileus and delayed gastric emptying, urine retention.



Paracetamol	10 - 15 mg/kg/dose every 6 hours as needed.	the analgesic effect is believed to be due to activation of descending serotonergic inhibitory pathways in the CNS.	Although data are limited for neonates, in children liver toxicity occurs with excessive doses or after prolonged administration.
Ketamine	<i>Limited data available:</i> IV: 0.5 - 2 mg/kg/dose	Ketamine is a noncompetitive NMDA receptor antagonist that blocks glutamate. Reduces polysynaptic spinal reflexes.	confusion, delirium, dreamlike state, excitement, hallucinations, irrational behavior, vivid imagery

Dyspnea			
Name of Drug	Dosage	Mechanism of Action	Adverse Effects
Fentanyl	Single or intermittent: 0.5 - 3 mcg/kg per dose slow IV push. May repeat every 2 to 4 hours Continuous infusion: 0.5 - 2 mcg/kg/hr. Max dose: 3 mcg/kg/hr.	Binds with stereospecific receptors at many sites within the CNS, increases pain threshold, alters pain reception, inhibits ascending pain pathways	Chest wall rigidity, Respiratory depression occurs on high doses, Urinary retention, Tolerance may develop to analgesic doses with prolonged use; wean slowly.
Morphine	Single or intermittent: 0.05 - 0.2 mg/kg per dose IV, IM, or subQ. May repeat every 4 to 6 hours. 0.08 mg/kg per dose PO every 4-6 hours. Continuous infusion: 0.01 - 0.02 mg/kg/hr. Max dose: 0.03 mcg/kg/hr Buccal: 1/3 - 1/2 oral dosage	Binds to opioid receptors in the CNS, causing inhibition of ascending pain pathways, altering the perception of and response to pain; produces generalized CNS depression Use IV solution Rapid absorption, useful first line if no IV access available/appropriate	respiratory depression, hypotension and bradycardia. Ileus and delayed gastric emptying, urine retention. Tolerance may develop after prolonged use; wean slowly.
Methadone	Neonatal Abstinence Syndrome- Initial dose: 0.05 to 0.1 mg/kg per dose orally every 6 to 24 hours. Adjust dose (in 10% to 20% increments) and weaning schedule based on signs and symptoms of withdrawal	Binds to opiate receptors in the CNS, causing inhibition of ascending pain pathways, altering the perception of and response to pain; produces generalized CNS depression. Methadone has also been shown to have N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonism	Respiratory depression in excessive doses. Ileus and delayed gastric emptying, urine retention.



Irritability / Agitation			
Name of Drug	Dosage	Mechanism of Action	Adverse Effects
Midazolam	IV: 0.05 - 0.15 mg/kg. May repeat every 2 to 4 hours. Continuous IV infusion: 0.01 - 0.06 mg/kg per hour (0.1 - 1 mcg/kg/min).	Short-acting benzodiazepine with rapid onset of action. Sedative and anticonvulsant properties related to GABA accumulation and occupation of benzodiazepine receptor. Can use IV solution Rapid absorption, useful first line if no IV access available/appropriate	Respiratory depression and hypotension are common when used in conjunction with narcotics, or following rapid bolus administration Seizures may occur
Clonazepam (Rivotril)	Initial: 0.01 - 0.03 mg/kg/day in divided doses up to 3 to 4 times daily; increase dose to desired effect up to a maximum daily dose: 0.2 mg/kg/day in 3 divided doses.	enhances the activity of inhibitory effect of GABA on neuronal excitability.	drowsiness, ataxia, behavioral problems and dizziness.
Clonidine	Initial: 0.5 - 1 mcg/kg, followed by 0.5 to 1.25 mcg/kg/dose orally every 4 to 6 hours.	Clonidine is a centrally acting alpha-2-adrenergic agonist, resulting in decreased sympathetic outflow from the CNS and a decrease in peripheral resistance, heart rate, and blood pressure.	bradycardia, hypotension agitation and irritability.
Dexmedetomidine (Precedex)	IV: Loading doses of 0.05 - 0.2 mcg/kg over 10-20 minutes, followed by 0.05 - 0.6 mcg/kg/hr IV (adjust dose to desired level of sedation)	Selective alpha ₂ adrenergic agonist and activation of the receptor results in sedation.	Bradycardia hypotension

Seizures			
Name of Drug	Dosage	Mechanism of Action	Adverse Effects
Phenobarbital	Loading dose: 20 mg/kg orally, IV on day one. With options for two half loading doses. Maintenance: 3-5 mg/kg/day IV or PO in 1 to 2 divided doses	depresses CNS activity by binding to barbiturate site at GABA receptor complex enhancing GABA activity; depresses reticular activating system; higher doses may be gabamimetic.	bradycardia, hypotension, agitation and central nervous system depression.



	started 12 hours after the loading dose		
Midazolam	Loading dose: 0.15 mg/kg (150 mcg/kg) IV, followed by maintenance dose. Maintenance infusion: 0.06 - 0.4 mg/kg per hour (1 to 7 mcg/kg per minute).	Short-acting benzodiazepine with rapid onset of action. Sedative and anticonvulsant properties related to GABA accumulation and occupation of benzodiazepine receptor. Can use IV solution Rapid absorption, useful first line if no IV access available/appropriate	Respiratory depression and hypotension are common when used in conjunction with narcotics, or following rapid bolus administration

Spasticity

Name of Drug	Dosage	Mechanism of Action	Adverse Effects
Clonidine	Initial, 0.5 to 1 mcg/kg, followed by 0.5 to 1.25 mcg/kg/dose orally every 4 to 6 hours	Clonidine is a centrally acting alpha-2-adrenergic agonist, resulting in decreased sympathetic outflow from the CNS and a decrease in peripheral resistance, heart rate, and blood pressure.	Bradycardia hypotension agitation and irritability

Airway Secretions

Name of Drug	Dosage	Mechanism of Action	Adverse Effects
Glycopyrrolate	Limited data available: PO: 20 – 100 mcg/kg/dose, 3-4 doses a day	Glycopyrrolate is an anticholinergic agent which inhibits the acetylcholine activity on smooth muscles and structures innervated by postganglionic nerves	Flushing, urinary retention
Scopolamine	Limited data available: Children ≥3 years	Blocks the action of acetylcholine at parasympathetic sites in	Drowsiness, dizziness mydriasis,



	and Adolescents: Transdermal: Initial: Apply $\frac{1}{4}$ patch every 3 days for 1 week; may titrate to effect (control of secretions) by increasing by $\frac{1}{4}$ patch every 7 days as tolerated	smooth muscle, secretory glands and the CNS.	hallucinations, Xerostomia
Atropine	sublingual: 1 to 2 drops (=0.25 to 0.5 mg) of diluted Atropine 0.5% every 6 hours	Atropine is an anticholinergic medication that reduces saliva production by blocking the muscarinic (M3) receptor sites on the salivary glands	Flushing, photophobia, dizziness tachycardia.